

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis.
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
3	Amphotericin B Deoxycholate (Kháng nấm)	Tĩnh mạch	Aspergillosis phổ biến	0,6 – 0,7 mg/kg mỗi 24 giờ (3 – 6 tháng)	Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan Bệnh nhân rối loạn chức năng thận do thuốc: giảm 50% tổng liều hàng ngày	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Blastomycosis: Bệnh phổi nặng, bệnh ngoài phổi lan toả	0,7 – 1 mg/kg mỗi 24 giờ (1 – 2 tuần)			
			Nấm Candida xâm lấn	0,5 – 0,7 mg/kg mỗi 24 giờ			
			Nấm C.glabrata hoặc C.krusei	1 mg/kg mỗi 24 giờ			
			Viêm bề thận, viêm bàng quang do C. krusei hoặc C.glabrata kháng fluconazole	0,3 – 0,6 mg/kg mỗi 24 giờ (1 – 7 ngày)			
4	Amphotericin B lipid complex (Kháng nấm)	Tĩnh mạch	Aspergillosis xâm lấn	5 mg/kg mỗi 24 giờ (6 – 12 tuần)	Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan và suy thận	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Nấm Candida, bệnh nhân không giảm bạch cầu trung tính	3 – 5 mg/kg mỗi 24 giờ, có thể chuyển sang fluconazole (sau 5-7 ngày)			
			Nấm Candida, bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính	3 – 5 mg/kg mỗi 24 giờ, có thể chuyển sang fluconazole (khi lâm sàng ổn định)			
			Nghi ngờ nhiễm nấm Candida xâm lấn, bệnh nhân ICU không giảm bạch cầu	3 – 5 mg/kg mỗi 24 giờ (trong 14 ngày)			
			Nấm Candida ổ bụng	3-5 mg/kg mỗi 24 giờ (khi lâm sàng ổn định)			
			Phổi cấp tính (vừa đến nặng)	3-5 mg/kg mỗi 24 giờ (1-2 tuần) sau đó là itraconazole			

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC																													
5	Ampicillin Sulbactam (Kháng sinh, Penicillin)	Tĩnh mạch	Nhiễm trùng vết thương (vết cần động vật hoặc người)	1,5g – 3g mỗi 6 giờ (5 – 14 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan <table><tr><th>CrCl (ml/ph/1.73m²)</th><th>Liều dùng trên suy thận</th></tr><tr><td>>30</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>15 – 29</td><td>1,5 – 3 g mỗi 12 giờ</td></tr><tr><td>5 - 14</td><td>1,5 – 3 g mỗi 24 giờ</td></tr></table>		CrCl (ml/ph/1.73m ²)	Liều dùng trên suy thận	>30	Không cần hiệu chỉnh	15 – 29	1,5 – 3 g mỗi 12 giờ	5 - 14	1,5 – 3 g mỗi 24 giờ	<table><tr><th>IHD</th></tr><tr><td>1,5 – 3g mỗi 12 – 24 giờ</td></tr></table>	IHD	1,5 – 3g mỗi 12 – 24 giờ	<table><tr><th colspan="2">CVVH</th></tr><tr><td>Liều tải</td><td>3g</td></tr><tr><td>Duy trì</td><td>1,5 – 3g mỗi 8 - 12 giờ</td></tr><tr><th colspan="2">CVVHD</th></tr><tr><td>Liều tải</td><td>3g</td></tr><tr><td>Duy trì</td><td>1,5 – 3g mỗi 8 giờ</td></tr><tr><th colspan="2">CVVHDF</th></tr><tr><td>Liều tải</td><td>3g</td></tr><tr><td>Duy trì</td><td>1,5 – 3g mỗi 6 – 8 giờ</td></tr></table>		CVVH		Liều tải	3g	Duy trì	1,5 – 3g mỗi 8 - 12 giờ	CVVHD		Liều tải	3g	Duy trì	1,5 – 3g mỗi 8 giờ	CVVHDF		Liều tải	3g	Duy trì	1,5 – 3g mỗi 6 – 8 giờ
			CrCl (ml/ph/1.73m ²)	Liều dùng trên suy thận																																	
			>30	Không cần hiệu chỉnh																																	
			15 – 29	1,5 – 3 g mỗi 12 giờ																																	
			5 - 14	1,5 – 3 g mỗi 24 giờ																																	
			IHD																																		
1,5 – 3g mỗi 12 – 24 giờ																																					
CVVH																																					
Liều tải	3g																																				
Duy trì	1,5 – 3g mỗi 8 - 12 giờ																																				
CVVHD																																					
Liều tải	3g																																				
Duy trì	1,5 – 3g mỗi 8 giờ																																				
CVVHDF																																					
Liều tải	3g																																				
Duy trì	1,5 – 3g mỗi 6 – 8 giờ																																				
Nhiễm trùng máu	3g mỗi 6 giờ (7 – 14 ngày)																																				
Nhiễm trùng do Acinetobacter spp.	3g mỗi 4 giờ (7 – 14 ngày)																																				
Viêm phổi cộng đồng	3g mỗi 6 giờ (tối thiểu 5 ngày)																																				
Viêm phổi bệnh viện	3g mỗi 6 giờ (7 ngày)																																				
Viêm phổi thở máy																																					
6	Azithromycin (Kháng sinh, Macrolid)	Uống	Giãn phế quản	500 mg x 3 lần/tuần hoặc 250 mg/ngày	Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan và suy thận	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều																														
			COPD	Liều tải: 500 mg vào ngày 1																																	
				Sau đó: 250 mg mỗi 24 giờ (2-5 ngày) hoặc 500 mg mỗi 24 giờ (3 ngày)																																	
			Dự phòng COPD	250 - 500 mg x 3lần/tuần																																	
			Viêm phổi cộng đồng	Ngày 1: 500 mg																																	
				Sau đó: 250 mg mỗi 24 giờ (4 ngày) hoặc 500 mg mỗi 24 giờ (3 ngày)																																	
Bệnh Lyme	500 mg mỗi 24 giờ (7 - 10 ngày)																																				

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD:Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC								
7	Caspofungin (Kháng nấm, Enchinocandin)	Tĩnh mạch	Aspergillosis xâm lấn	Liều tải: 70 mg vào ngày 1	Không cần hiệu chỉnh liều trên suy thận <table><tr><td>Child - Pugh A</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>Child - Pugh B</td><td>Liều tải: 70 mg</td></tr><tr><td>Child Pugh C</td><td>Duy trì: 35 mg/ngày</td></tr><tr><td></td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr></table>		Child - Pugh A	Không cần hiệu chỉnh	Child - Pugh B	Liều tải: 70 mg	Child Pugh C	Duy trì: 35 mg/ngày		Không cần hiệu chỉnh	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
				Child - Pugh A			Không cần hiệu chỉnh									
			Child - Pugh B	Liều tải: 70 mg												
			Child Pugh C	Duy trì: 35 mg/ngày												
				Không cần hiệu chỉnh												
			Sau đó: 50 mg mỗi 24 giờ (6-12 tuần)													
			Candida máu, nhiễm trùng Candida khác	Liều tải: 70 mg vào ngày 1												
				Sau đó: 50 mg mỗi 24 giờ (ít nhất 14 ngày, sau lần cấy máu dương tính cuối cùng)												
			Nhiễm Candida (bệnh nhân ICU không giảm bạch cầu)	Liều tải: 70 mg vào ngày 1												
				Sau đó: 50 mg mỗi 24 giờ (4-5 ngày)												
Dự phòng Candida xâm lấn (bệnh nhân ICU có nguy cơ cao)	Liều tải: 70 mg vào ngày 1															
	Sau đó: 50 mg mỗi 24 giờ															
8	Cefaclor (Kháng sinh, Cephalosporin 2)	Uống	Nhiễm trùng mắt cảm	Viên giải phóng ngay: 250-500 mg mỗi 8 giờ	Không cần hiệu chỉnh liều		<table><tr><td>ESRD, IHD</td></tr><tr><td>250 - 500 mg sau lọc</td></tr><tr><td>PD</td></tr><tr><td>250-500 mg mỗi 8 giờ</td></tr></table>	ESRD, IHD	250 - 500 mg sau lọc	PD	250-500 mg mỗi 8 giờ	Không cần hiệu chỉnh liều				
				ESRD, IHD												
			250 - 500 mg sau lọc													
			PD													
			250-500 mg mỗi 8 giờ													
			Viên giải phóng kéo dài: 500 mg mỗi 12 giờ													
			Đợt cấp của viêm phế quản mãn tính	Viên giải phóng kéo dài: 500 mg mỗi 12 giờ (7 ngày)												
			Nhiễm khuẩn thứ phát của viêm phế quản cấp tính													

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC						BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM												
STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU NGẮT QUẢNG		LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU LIÊN TỤC									
9	Cefazolin (Kháng sinh, Cephalosporin 1)	Tĩnh mạch	Nhiễm trùng máu do staphylococci nhạy methicillin	2 g mỗi 8 giờ (≥ 14 ngày, kể từ ngày cấy máu âm tính)	Không cần hiệu chỉnh liều trên suy gan				CVVH <table><tr><td>Liều tải</td><td>2g</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>1 - 2g mỗi 12 giờ</td></tr></table> CVVHD/CVVHDF <table><tr><td>Liều tải</td><td>2g</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>1g mỗi 8 giờ Hoặc 2g mỗi 12 giờ</td></tr></table>		Liều tải	2g	Sau đó	1 - 2g mỗi 12 giờ	Liều tải	2g	Sau đó	1g mỗi 8 giờ Hoặc 2g mỗi 12 giờ
			Liều tải	2g														
			Sau đó	1 - 2g mỗi 12 giờ														
			Liều tải	2g														
			Sau đó	1g mỗi 8 giờ Hoặc 2g mỗi 12 giờ														
			Nhiễm trùng máu do <i>Enterobacteriaceae</i>	2 g mỗi 8 giờ (7 – 14 ngày)														
			Viêm túi mật cấp	1-2g mỗi 8 giờ (lâm sàng cải thiện)														
			Nhiễm trùng ổ bụng: ruột thừa thủng, áp xe ruột thừa, viêm túi thừa	1-2g mỗi 8 giờ, kết hợp metronidazole (4 – 7 ngày)														
			Viêm tủy xương, viêm đĩa đệm do <i>S. aureus</i> nhạy methicillin	2 g mỗi 8 giờ (≥ 6 tuần)														
Viêm phổi do <i>S.aureus</i> nhạy methicillin	2 g mỗi 8 giờ (5 – 7 ngày)																	
Nhiễm trùng da và mô mềm do <i>S. aureus</i> nhạy methicillin	1-2g mỗi 8 giờ (5 – 14 ngày)																	
Nhiễm trùng da và mô mềm do <i>S. aureus</i> kháng methicillin	1-2g mỗi 8 giờ (5-14 ngày)																	
Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp: viêm bể thận	1g mỗi 8 giờ (5 – 14 ngày)																	
10	Cefoperazon (Kháng sinh, Cephalosporin 3)	Tĩnh mạch / Bắp	Nhiễm khuẩn da, mô mềm	1 – 2 g mỗi 12 giờ	Điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan		Không cần hiệu chỉnh liều		Không cần hiệu chỉnh liều									
			Bệnh viêm vùng chậu		Tắc mật nặng	≤ 2g/ngày												
			Nhiễm trùng hô hấp		Suy gan nặng kèm suy thận													
			Nhiễm khuẩn nặng	4 g/ ngày mỗi 12 giờ	Điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận													
					Liều thông thường 2-4g/ngày	Không chỉnh liều												
		GFR < 18 ml/phút	Tối đa 4g/ngày															
		Cr/máu > 3,5 mg/dL																

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC														
11	Cefoperazon/ Sulbactam (Kháng sinh kết hợp, Cephalosporin 3 và chất ức chế Beta lactam)	Tĩnh mạch / Bắp	Nhiễm khuẩn hô hấp	Liều thông thường Sulbactam 1-2g Cefoperazon 1-2g mỗi 12 giờ	<table><tr><th>CrCl (ml/ph)</th><th>Liều dùng trên suy thận</th></tr><tr><td>>30</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>15 – 30</td><td>Sulbactam 1g mỗi 12 giờ</td></tr><tr><td>< 15</td><td>Sulbactam 500 mg mỗi 12 giờ</td></tr></table>		CrCl (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận	>30	Không cần hiệu chỉnh	15 – 30	Sulbactam 1g mỗi 12 giờ	< 15	Sulbactam 500 mg mỗi 12 giờ	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều						
CrCl (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận																					
>30	Không cần hiệu chỉnh																					
15 – 30	Sulbactam 1g mỗi 12 giờ																					
< 15	Sulbactam 500 mg mỗi 12 giờ																					
Viêm phúc mạc																						
Viêm túi mật																						
Nhiễm khuẩn ổ bụng																						
Nhiễm khuẩn huyết	Nhiễm khuẩn nặng Cefoperazon 2g mỗi 12 giờ																					
Viêm màng não																						
Nhiễm khuẩn da, mô mềm																						
Nhiễm khuẩn xương khớp																						
Viêm vùng chậu																						
12	Cefotaxim (Kháng sinh, Cephalosporin 3)	Tĩnh mạch	Vết thương cần (động vật)	1-2 g mỗi 6 - 8 giờ, kết hợp clindamycin hoặc metronidazol	Không cần hiệu chỉnh liều trên suy gan <table><tr><th>GFR (ml/ph)</th><th>Liều dùng trên suy thận</th></tr><tr><td>> 50</td><td>Liều chỉ định mỗi 6 giờ</td></tr><tr><td>10 – 50</td><td>Liều chỉ định mỗi 6 – 12 giờ</td></tr><tr><td>< 10</td><td>Liều chỉ định mỗi 24 giờ Hoặc giảm 50% liều thông thường</td></tr></table>		GFR (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận	> 50	Liều chỉ định mỗi 6 giờ	10 – 50	Liều chỉ định mỗi 6 – 12 giờ	< 10	Liều chỉ định mỗi 24 giờ Hoặc giảm 50% liều thông thường	<table><tr><th>IHD</th></tr><tr><td>1-2g mỗi 24 giờ</td></tr></table> <table><tr><th>PD</th></tr><tr><td>1g mỗi 24 giờ</td></tr></table>	IHD	1-2g mỗi 24 giờ	PD	1g mỗi 24 giờ	<table><tr><th>CVVH</th></tr><tr><td>1-2g mỗi 8 - 12 giờ</td></tr></table>	CVVH	1-2g mỗi 8 - 12 giờ
GFR (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận																					
> 50	Liều chỉ định mỗi 6 giờ																					
10 – 50	Liều chỉ định mỗi 6 – 12 giờ																					
< 10	Liều chỉ định mỗi 24 giờ Hoặc giảm 50% liều thông thường																					
IHD																						
1-2g mỗi 24 giờ																						
PD																						
1g mỗi 24 giờ																						
CVVH																						
1-2g mỗi 8 - 12 giờ																						
Áp xe não	2g mỗi 6 – 8 giờ, kết hợp metronidazol	<table><tr><th>CVVHD</th></tr><tr><td>1-2g mỗi 8 giờ</td></tr></table> <table><tr><th>CVVHDF</th></tr><tr><td>1-2g mỗi 6 - 8 giờ</td></tr></table>	CVVHD	1-2g mỗi 8 giờ	CVVHDF	1-2g mỗi 6 - 8 giờ																
CVVHD																						
1-2g mỗi 8 giờ																						
CVVHDF																						
1-2g mỗi 6 - 8 giờ																						
Nhiễm trùng ổ bụng: ruột thừa thủng, viêm túi thừa, áp xe ổ bụng	2g mỗi 8 giờ, kết hợp metronidazol (4 - 7 ngày)																					
Viêm màng não do <i>Cutibacterium acnes</i> , <i>H.influenzae</i> , <i>N.meningitidis</i> , <i>S.pneumoniae</i> , <i>Gr(-)</i>	2g mỗi 6 – 8 giờ, kết hợp kháng sinh thích hợp																					
Viêm phổi cộng đồng do <i>P.aeruginosa</i>	1- 2g mỗi 8 giờ (5 ngày)																					
Nhiễm trùng huyết	2g mỗi 6 – 8 giờ																					
Nhiễm trùng đa bào	2g mỗi 6 giờ, kết hợp metronidazol hoặc clindamycin																					
Nhiễm trùng hoại tử do <i>Vibrio Vulnificus</i>	2g mỗi 8 giờ, kết hợp doxycyclin (lâm sàng cải thiện)																					

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis

IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.

CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.

PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;

CAPD:Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

6

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
13	Cefoxitin (Kháng sinh, Cephalosporin 2)	Tĩnh mạch	Vết thương cần (động vật)	1g mỗi 6 – 8 giờ	Không cần hiệu chỉnh liều trên suy gan		HD Liều tải: 1 - 2g sau mỗi lần lọc Liều duy trì: theo CrCl	Không cần hiệu chỉnh liều
			M. abscessus (bệnh phổi)	2g mỗi 4 giờ Hoặc 3g mỗi 6 giờ	Suy thận: Liều tải 1-2g Liều duy trì theo CrCl			
			M. abscessus (bệnh nhân xơ nang)	200 mg/kg/ngày chia 3 lần. Tối đa: 12g/ngày. (3 - 12 tuần)	CrCl (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận		
			Viêm vùng chậu	2g mỗi 6 giờ, kết hợp Doxycyclin ít nhất 24 - 48h sau cải thiện lâm sàng	30 – 50	1 - 2g mỗi 6 - 12 giờ		
					10 – 29	1 - 2g mỗi 12 - 24 giờ		
5 – 9	0,5 – 1g mỗi 12 - 24 giờ							
< 5	0,5 – 1g mỗi 24 - 48 giờ							
14	Cefpodoxim (Kháng sinh, Cephalosporin 2)	Uống	COPD	200 mg mỗi 12 giờ (3 – 7 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều trên suy gan		HD Liều 3 lần/ tuần sau lọc máu	Không cần hiệu chỉnh liều
			Viêm phổi cộng đồng	200 mg mỗi 12 giờ (5 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều trên suy gan			
			Nhiễm trùng da và mô mềm	400 mg mỗi 12 giờ (7 – 14 ngày)	CrCl (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận		
			Viêm bàng quang không biến chứng cấp	100 mg mỗi 12 giờ (5 – 7 ngày)	≥ 30	Không cần hiệu chỉnh		
					< 30	Dùng liều chỉ định mỗi 24 giờ		
			Viêm bể thận cấp, nhiễm trùng tiết niệu phức tạp khác	200 mg mỗi 12 giờ (10 – 14 ngày)				

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN			LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC														
15	Ceftazidim (Kháng sinh, Cephalosporin 3)	Tĩnh mạch	Nhiễm trùng máu Gr(-), P.aeruginosa	2 g mỗi 8 giờ (7 – 14 ngày)	Không chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan			IHD 500 mg - 1g mỗi 24 giờ, sau chạy thận Ngoài ra 1g x 3 lần/tuần, sau mỗi lần lọc máu Hoặc 2 g mỗi 72 giờ (khi có kháng thuốc)		CVVH/CVVHD/ CVVHDF IV: 2 g mỗi 8 – 12 giờ (MIC cao hoặc nhiễm trùng nặng) Ngoài ra Liều tải 2 g Sau đó 3 g mỗi 24 giờ (truyền liên tục)														
			Xơ nang, làm nặng phổi cấp tính	2g mỗi 6 - 8 giờ (10 ngày – 3 tuần)																				
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường (trung bình đến nặng)	1 - 2 g mỗi 8 giờ (2 – 4 tuần)																				
			Viêm túi mật cấp	2g mỗi 8 giờ (khi lâm sàng ổn định)																				
			Viêm đường mật	2g mỗi 8 giờ. Kết hợp Metronidazole (4 - 7 ngày)																				
			Viêm túi thừa																					
			Áp xe trong ổ bụng	2g mỗi 8 giờ (4 – 8 tuần)	Chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận <table><tr><th>CICr (ml/ph)</th><th>Liều 1g mỗi 8 giờ</th><th>Liều 2g mỗi 8 giờ</th></tr><tr><td>>50</td><td>Không cần chỉnh liều</td><td>Không cần chỉnh liều</td></tr><tr><td>31 – 50</td><td>1 g mỗi 12 giờ</td><td>2 g mỗi 12 giờ</td></tr><tr><td>16 – 30</td><td>1 g mỗi 24 giờ</td><td>2 g mỗi 24 giờ</td></tr><tr><td>≤ 15</td><td>500 mg mỗi 24 giờ</td><td>1 g mỗi 24 giờ</td></tr></table>			CICr (ml/ph)	Liều 1g mỗi 8 giờ	Liều 2g mỗi 8 giờ	>50	Không cần chỉnh liều	Không cần chỉnh liều	31 – 50	1 g mỗi 12 giờ	2 g mỗi 12 giờ	16 – 30	1 g mỗi 24 giờ	2 g mỗi 24 giờ	≤ 15	500 mg mỗi 24 giờ	1 g mỗi 24 giờ	PD 1 g mỗi 24 giờ	
			CICr (ml/ph)					Liều 1g mỗi 8 giờ	Liều 2g mỗi 8 giờ															
			>50					Không cần chỉnh liều	Không cần chỉnh liều															
			31 – 50	1 g mỗi 12 giờ				2 g mỗi 12 giờ																
			16 – 30	1 g mỗi 24 giờ				2 g mỗi 24 giờ																
			≤ 15	500 mg mỗi 24 giờ	1 g mỗi 24 giờ																			
			Áp xe nội sọ, Áp xe não, Áp xe ngoài màng cứng																					
			Viêm màng não	Kết hợp Vancomycin (10 – 14 ngày)																				
			Viêm tủy xương	2g mỗi 8 giờ (6 tuần)																				
Viêm đĩa đệm																								
Viêm phổi cộng đồng, Gr(-) kháng thuốc, P.aeruginosa	2g mỗi 8 giờ (tối thiểu 5 ngày)	PD 1 g mỗi 24 giờ																						
Viêm phổi bệnh viện, Viêm phổi thở máy, Gr (-) kháng thuốc, P.aeruginosa	2g mỗi 8 giờ (7 ngày)																							
Nhiễm trùng da, mô mềm	2g mỗi 8 giờ (10-14 ngày)																							
Nhiễm trùng tiết niệu (viêm bể thận)	1 - 2g mỗi 8 giờ (5 – 14 ngày)																							
Nhiễm trùng tiết niệu (P.aeruginosa)	2g mỗi 8 giờ (5 – 14 ngày)																							

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
16	Ceftriaxon (Kháng sinh, Cephalosporin 3)	Tĩnh mạch/ Bắp	Nhiễm trùng vết thương, vết cắn	2 g mỗi 24 giờ hoặc 1 g mỗi 12 giờ (5 – 14 ngày)	Bệnh nhân vừa suy thận vừa suy gan, liều hàng ngày không quá 2 g	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Nhiễm trùng máu, không nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương	2 g mỗi 24 giờ (7 – 14 ngày)			
			Nhiễm phế cầu khuẩn	2 g mỗi 12 giờ, kết hợp vancomycin (đến khi viêm màng não được loại trừ)			
			COPD (không do <i>P.aeruginosa</i>)	1 g mỗi 24 giờ (5 – 7 ngày)			
			Viêm túi mật cấp	1 – 2 g mỗi 24 giờ (lâm sàng ổn định)			
			Nhiễm trùng ổ bụng: viêm túi thừa, áp xe ổ bụng, ruột thừa thủng	1 – 2 g mỗi 24 giờ, kết hợp metronidazole (4 – 7 ngày)			
			Áp xe nội sọ: áp xe não, áp xe ngoài màng cứng	2g mỗi 12 giờ (4 – 8 tuần)			
			Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp, viêm bể thận	1g mỗi 24 giờ (5 – 14 ngày)			
			Viêm màng não: <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>	2 g mỗi 12 giờ, kết hợp kháng sinh khác			
			Viêm phổi mắc phải cộng đồng (không do <i>P. aeruginosa</i>)	1 – 2 g mỗi 24 giờ, kết hợp kháng sinh khác (tối thiểu 5 ngày)			
			Nhiễm khuẩn <i>Salmonella</i>	2 g mỗi 12 – 24 giờ (10 – 14 ngày)			
			Nhiễm trùng máu <i>Salmonella</i>	1 – 2g mỗi 24 giờ (14 ngày)			
			Nhiễm trùng da và mô mềm	2 g mỗi 24 giờ (7 ngày)			
			Nhiễm trùng da mô mềm toàn thân	2 g mỗi 24 giờ (≥ 4 tuần: 14 ngày đường tiêm, sau là uống)			
			Viêm phúc mạc do vi khuẩn tự phát	2 g mỗi 24 giờ (5 ngày)			

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD:Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC								
17	Cefuroxim (Kháng sinh, Cephalosporin 2	Tĩnh mạch/ Uống	Vết cắn (động vật, người)	Uống: 500 mg mỗi 12 giờ (3 - 5 ngày)	Đường uống <table><tr><td>CICr (ml/ph)</td><td>Liều hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>≥ 30</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>10 – 30</td><td>Liều khuyến cáo trên chỉ định mỗi 24 giờ</td></tr><tr><td>< 10</td><td>Liều khuyến cáo trên chỉ định mỗi 48 giờ</td></tr></table>		CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh	≥ 30	Không cần hiệu chỉnh	10 – 30	Liều khuyến cáo trên chỉ định mỗi 24 giờ	< 10	Liều khuyến cáo trên chỉ định mỗi 48 giờ	IHD Liều khuyến cáo dựa trên chỉ định đưa cuối buổi lọc máu	Hemodialysis Liều khuyến cáo dựa trên chỉ định, đưa cuối buổi lọc máu
			CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh												
			≥ 30	Không cần hiệu chỉnh												
			10 – 30	Liều khuyến cáo trên chỉ định mỗi 24 giờ												
			< 10	Liều khuyến cáo trên chỉ định mỗi 48 giờ												
			Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính	Uống 250 – 500 mg mỗi 12 giờ (3-7 ngày)	Peritoneal dialysis Dùng đủ liều mỗi 24 giờ											
			Viêm túi mật cấp	IV: 1,5g mỗi 8 giờ		CRRT 1 g mỗi 12 giờ										
Nhiễm trùng ổ bụng	IV: 1,5g mỗi 8 giờ kết hợp Metronidazole (4 – 7 ngày)															
Viêm tai giữa cấp	Uống: 500 mg mỗi 12 giờ (5-7 ngày)															
Viêm phổi cộng đồng	Uống: 500 mg mỗi 12 giờ (5-7 ngày)															
Nhiễm trùng tiết niệu	Uống: 250 mg mỗi 12 giờ (5-7 ngày)															
18	Ciprofloxacin (Kháng sinh, Fluoroquinolon)	Tĩnh mạch/Uống	Nhiễm trùng vết thương, điều trị vết cắn động vật, người	Uống: 500-750 mg mỗi 12 giờ IV: 400mg mỗi 12 giờ (Dự phòng: 3-5 ngày) (Điều trị: 5-14 ngày)	Không chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan Uống viên giải phóng ngay <table><tr><td>CICr (ml/ph)</td><td>Liều hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>>50</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>30 – 50</td><td>250 – 500 mg mỗi 12 giờ</td></tr><tr><td>5 - 29</td><td>250 – 500 mg mỗi 18 giờ</td></tr></table>		CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh	>50	Không cần hiệu chỉnh	30 – 50	250 – 500 mg mỗi 12 giờ	5 - 29	250 – 500 mg mỗi 18 giờ	IHD/PD Uống viên giải phóng ngay 250 – 500 mg mỗi 24 giờ IHD/PD Uống viên giải phóng kéo dài 500 mg mỗi 24 giờ	CVVH / CVVHD / CVVHDF IV: 200 - 400 mg mỗi 12 - 24 giờ
			CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh												
			>50	Không cần hiệu chỉnh												
			30 – 50	250 – 500 mg mỗi 12 giờ												
			5 - 29	250 – 500 mg mỗi 18 giờ												
			COPD, nguy cơ nhiễm Pseudomonas	Uống: 500-750 mg mỗi 12 giờ (3-7 ngày)												
			Bệnh Crohn, lỗ rò quanh hậu môn	Uống: 500 mg mỗi 12 giờ (4 tuần), kết hợp Metronidazole												
Nhiễm trùng chân do tiểu đường, nghi ngờ Pseudomonas aeruginosa	Nhẹ: Uống 750 mg mỗi 12 giờ Nặng: IV 400 mg mỗi 8 giờ															
Nhiễm trùng ổ bụng: thủng ruột thừa, áp xe ruột thừa, viêm túi thừa cấp, viêm túi mật cấp (mắc cộng đồng)	Uống: 500 mg mỗi 12 giờ IV: 400mg mỗi 12 giờ (4 – 7 ngày)															

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN			LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC																						
	Ciprofloxacin (Kháng sinh, Fluoroquinolon)		Viêm màng não (mắc cộng đồng)	IV: 400 mg mỗi 8 – 12 giờ (kết hợp kháng sinh thích hợp)	<table><tr><td colspan="3">Uống viên giải phóng kéo dài</td></tr><tr><td>CICr (ml/ph)</td><td colspan="2">Liều hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>>30</td><td colspan="2">Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td rowspan="2">≤ 30</td><td>Viêm bàng quang cấp tính, không biến chứng</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>Viêm tiết niệu phức tạp: viêm bể thận</td><td>500 mg mỗi 24 giờ</td></tr></table>			Uống viên giải phóng kéo dài			CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh		>30	Không cần hiệu chỉnh		≤ 30	Viêm bàng quang cấp tính, không biến chứng	Không cần hiệu chỉnh	Viêm tiết niệu phức tạp: viêm bể thận	500 mg mỗi 24 giờ	<table><tr><td colspan="2">Hoặc</td></tr><tr><td colspan="2">IHD</td></tr><tr><td>Uống</td><td>250 – 500 mg mỗi 24 giờ</td></tr><tr><td>IV</td><td>200 – 400 mg mỗi 24 giờ</td></tr></table>		Hoặc		IHD		Uống	250 – 500 mg mỗi 24 giờ	IV	200 – 400 mg mỗi 24 giờ
Uống viên giải phóng kéo dài																															
CICr (ml/ph)		Liều hiệu chỉnh																													
>30		Không cần hiệu chỉnh																													
≤ 30		Viêm bàng quang cấp tính, không biến chứng	Không cần hiệu chỉnh																												
		Viêm tiết niệu phức tạp: viêm bể thận	500 mg mỗi 24 giờ																												
Hoặc																															
IHD																															
Uống		250 – 500 mg mỗi 24 giờ																													
IV		200 – 400 mg mỗi 24 giờ																													
	Dự phòng viêm màng não do mô cầu	Uống: 500 mg một liều duy nhất																													
	Viêm tuỷ xương do Pseudomonas aeruginosa	Uống: 750 mg mỗi 12 giờ (> 6 tuần) IV: 400 mg mỗi 8 giờ (≥ 6 tuần)																													
	Viêm phổi do Pseudomonas aeruginosa	Uống: 750 mg mỗi 12 giờ (7 ngày) Kết hợp kháng sinh thích hợp																													
		IV: 400 mg mỗi 8 giờ (7 ngày). Kết hợp kháng sinh thích hợp																													
	Nhiễm khuẩn thông thường	400 mg mỗi 12 giờ	<table><tr><td colspan="2">IV</td></tr><tr><td>CICr (ml/ph)</td><td>Liều hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>≥ 30</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>5 - 29</td><td>200 – 400 mg mỗi 18 – 24 giờ</td></tr></table>			IV		CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh	≥ 30	Không cần hiệu chỉnh	5 - 29	200 – 400 mg mỗi 18 – 24 giờ																		
IV																															
CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh																														
≥ 30	Không cần hiệu chỉnh																														
5 - 29	200 – 400 mg mỗi 18 – 24 giờ																														
	Nhiễm trùng vị trí phẫu thuật	Uống: 750mg mỗi 12 giờ																													
		IV: 400mg mỗi 12 giờ kết hợp Metronidazole	<table><tr><td colspan="2">Hoặc</td></tr><tr><td colspan="2">Uống viên giải phóng ngay/ IV</td></tr><tr><td>CICr (ml/ph)</td><td>Liều hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>> 50</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>10 – 50</td><td>50% - 75% liều thông thường mỗi 12 giờ</td></tr><tr><td>< 10</td><td>50% liều thông thường mỗi 12 giờ</td></tr></table>			Hoặc		Uống viên giải phóng ngay/ IV		CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh	> 50	Không cần hiệu chỉnh	10 – 50	50% - 75% liều thông thường mỗi 12 giờ	< 10	50% liều thông thường mỗi 12 giờ														
Hoặc																															
Uống viên giải phóng ngay/ IV																															
CICr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh																														
> 50	Không cần hiệu chỉnh																														
10 – 50	50% - 75% liều thông thường mỗi 12 giờ																														
< 10	50% liều thông thường mỗi 12 giờ																														
	Viêm bàng quang cấp tính không có biến chứng	Uống viên giải phóng ngay: 250 mg mỗi 12 giờ (3 ngày)																													
		Uống viên giải phóng kéo dài: 500 mg mỗi 24 giờ (3 ngày)																													
	Viêm bể thận cấp tính, viêm đường tiết niệu phức tạp	Uống viên giải phóng ngay: 500 mg mỗi 12 giờ (5 - 7 ngày)																													
		Uống viên giải phóng kéo dài: 1g mỗi 24 giờ (5 - 7 ngày)																													
		IV: 400mg mỗi 12 giờ (5 - 7 ngày)																													

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
19	Clindamycin (Kháng sinh, Lincosamid)	Tĩnh mạch/ Uống	Viêm màng não	900 mg mỗi 8 giờ (2 – 3 tuần),(Kết hợp kháng sinh thích hợp)	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Vết thương cần động vật, người	Uống: 300 – 450 mg mỗi 8 giờ			
				IV: 600 mg mỗi 6 – 8 giờ Dự phòng: 3 – 5 ngày Điều trị: 5 – 14 ngày			
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường	Uống: 300 – 450 mg mỗi 6 – 8 giờ (1 – 2 tuần)			
			Viêm tuỷ xương do <i>S.aureus</i> kháng methicillin (MRSA)	IV, Uống: 600 mg mỗi 8 giờ (tối thiểu 8 tuần)			
			Viêm tuỷ xương do <i>Staphylococcus aureus</i> <i>mẫn cảm</i> methicillin	IV: 600 – 900 mỗi 8 giờ (6 tuần)			
				Uống: 300 – 450 mg mỗi 6 giờ			
			Viêm tuỷ xương, đốt sống tự nhiên do <i>Cutibacterium acnes</i>	IV: 600 – 900 mg mỗi 8 giờ (6 tuần)			
			Viêm vùng chậu (nặng)	IV: 900 mg mỗi 8 giờ, kết hợp gentamicin. Sau 24-48 giờ, cải thiện lâm sàng, chuyển sang uống: 400 mg mỗi 6 giờ (hoặc doxycycline) (14 ngày)			
			Viêm phổi do <i>Pneumocytis jiroveci</i> (Nhẹ - Trung bình)	Uống: 450 mg mỗi 6 giờ hoặc 600 mg mỗi 8 giờ, kết hợp với primaquin (21 ngày)			

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD:Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
	Clindamycin (Kháng sinh, Lincosamid)		Viêm phổi do <i>Pneumocytis jiroveci</i> (nặng)	IV: 600 mg mỗi 6 giờ hoặc 900 mg mỗi 8 giờ, kết hợp với primaquin (21 ngày) Lâm sàng cải thiện, chuyển sang uống	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Viêm phổi do MRSA	IV: 600 mg mỗi 8 giờ (7 ngày)			
			Viêm mô tế bào không mũ, viêm quầng do <i>streptococci beta tán huyết</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> (gồm MRSA)	Uống: 300 mg x 4 lần/ngày hoặc 450 mg x 3 lần/ngày IV: 600 – 900 mg mỗi 8 giờ			
			Viêm mô tế bào có mũ hoặc áp xe do <i>Staphylococcus aureus</i> (gồm MRSA), <i>streptococci beta tán huyết</i>	Uống: 300 mg x 4 lần/ngày hoặc 450 mg x 3 lần/ngày (5 –14 ngày) Kết hợp kháng sinh thích hợp, khi nhiễm trùng toàn thân, áp xe lớn, viêm nội tâm mạc			
			Nhiễm trùng mô mềm hoại tử	IV: 600 – 900 mg mỗi 8 giờ. Kết hợp kháng sinh thích hợp, phẫu thuật sớm, loại bỏ mô hoại tử			
			Nhiễm trùng máu do <i>Streptococcus</i>	IV: 900 mg mỗi 8 giờ, kết hợp IV Penicillin G. Sau 48 giờ, BN không sốc nhiễm trùng, suy nội tạng, nhiễm trùng hoại tử: Dừng clindamycin, tiếp tục Penicillin G (≥ 14 ngày)			

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG	LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC																																																																										
20	Colistin (Kháng sinh, polypeptid)	Tĩnh mạch / Khí dung	<table><tr><th colspan="2">Bảng quy đổi</th></tr><tr><th>Liều Colistimethate Sodium (UI)</th><th>Colistin – Base Activity (CBA)(mg)</th></tr><tr><td>12.500</td><td>0.4</td></tr><tr><td>150.000</td><td>5</td></tr><tr><td>1.000.000</td><td>34</td></tr><tr><td>4.500.000</td><td>150</td></tr><tr><td>9.000.000</td><td>300</td></tr></table>	Bảng quy đổi		Liều Colistimethate Sodium (UI)	Colistin – Base Activity (CBA)(mg)	12.500	0.4	150.000	5	1.000.000	34	4.500.000	150	9.000.000	300	Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan <table><tr><th colspan="3">Chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận</th></tr><tr><th>Liều</th><th>CBA (mg/ngày)</th><th>Colistimethate Sodium (UI/ngày)</th></tr><tr><td>Liều tải</td><td>300 mg CBA</td><td>9.000.000</td></tr><tr><td>Duy trì</td><td colspan="2">Tổng liều duy trì chia 2 lần, theo bảng dưới đây</td></tr></table> <table><tr><th>Clcr (ml/ph)</th><th>CBA (mg/ngày)</th><th>Colistimethate Sodium (UI/ngày)</th></tr><tr><td>≥ 90</td><td>360</td><td>10.800.000</td></tr><tr><td>80 – 90</td><td>340</td><td>10.200.000</td></tr><tr><td>70 – 80</td><td>300</td><td>9.000.000</td></tr><tr><td>60 – 70</td><td>275</td><td>8.250.000</td></tr><tr><td>50 – 60</td><td>245</td><td>7.350.000</td></tr><tr><td>40 – 50</td><td>220</td><td>6.600.000</td></tr><tr><td>30 – 40</td><td>195</td><td>5.850.000</td></tr><tr><td>20 – 30</td><td>175</td><td>5.250.000</td></tr><tr><td>10 – 20</td><td>160</td><td>4.800.000</td></tr><tr><td>5 – 10</td><td>145</td><td>4.350.000</td></tr><tr><td>< 5</td><td>130</td><td>3.900.000</td></tr></table>	Chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận			Liều	CBA (mg/ngày)	Colistimethate Sodium (UI/ngày)	Liều tải	300 mg CBA	9.000.000	Duy trì	Tổng liều duy trì chia 2 lần, theo bảng dưới đây		Clcr (ml/ph)	CBA (mg/ngày)	Colistimethate Sodium (UI/ngày)	≥ 90	360	10.800.000	80 – 90	340	10.200.000	70 – 80	300	9.000.000	60 – 70	275	8.250.000	50 – 60	245	7.350.000	40 – 50	220	6.600.000	30 – 40	195	5.850.000	20 – 30	175	5.250.000	10 – 20	160	4.800.000	5 – 10	145	4.350.000	< 5	130	3.900.000	<table><tr><th colspan="2">IHD</th></tr><tr><td>Liều tải</td><td>300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>130 mg CBA mỗi 24 giờ Hoặc 3.900.000 UI mỗi 24 giờ</td></tr></table>	IHD		Liều tải	300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI	Sau đó	130 mg CBA mỗi 24 giờ Hoặc 3.900.000 UI mỗi 24 giờ	<table><tr><th colspan="2">CVVH/CVVHD/ CVVHDF</th></tr><tr><td>Liều tải</td><td>300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>220 mg CBA mỗi 12 giờ Hoặc 6.600.000 UI mỗi 12 giờ</td></tr></table>	CVVH/CVVHD/ CVVHDF		Liều tải	300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI	Sau đó	220 mg CBA mỗi 12 giờ Hoặc 6.600.000 UI mỗi 12 giờ
			Bảng quy đổi																																																																													
Liều Colistimethate Sodium (UI)	Colistin – Base Activity (CBA)(mg)																																																																															
12.500	0.4																																																																															
150.000	5																																																																															
1.000.000	34																																																																															
4.500.000	150																																																																															
9.000.000	300																																																																															
Chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận																																																																																
Liều	CBA (mg/ngày)	Colistimethate Sodium (UI/ngày)																																																																														
Liều tải	300 mg CBA	9.000.000																																																																														
Duy trì	Tổng liều duy trì chia 2 lần, theo bảng dưới đây																																																																															
Clcr (ml/ph)	CBA (mg/ngày)	Colistimethate Sodium (UI/ngày)																																																																														
≥ 90	360	10.800.000																																																																														
80 – 90	340	10.200.000																																																																														
70 – 80	300	9.000.000																																																																														
60 – 70	275	8.250.000																																																																														
50 – 60	245	7.350.000																																																																														
40 – 50	220	6.600.000																																																																														
30 – 40	195	5.850.000																																																																														
20 – 30	175	5.250.000																																																																														
10 – 20	160	4.800.000																																																																														
5 – 10	145	4.350.000																																																																														
< 5	130	3.900.000																																																																														
IHD																																																																																
Liều tải	300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI																																																																															
Sau đó	130 mg CBA mỗi 24 giờ Hoặc 3.900.000 UI mỗi 24 giờ																																																																															
CVVH/CVVHD/ CVVHDF																																																																																
Liều tải	300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI																																																																															
Sau đó	220 mg CBA mỗi 12 giờ Hoặc 6.600.000 UI mỗi 12 giờ																																																																															
			<table><tr><td>Nhiễm trùng nhạy cảm</td><td>2.5 đến 5 mg CBA/kg/ngày chia thành 2 đến 4 liều (tiêm bắp, tĩnh mạch)</td></tr><tr><td>Giãn phế quản</td><td>Khí dung: 30 -150 mg CBA, 1 -2 lần/ngày (Tối đa: 150 mg CBA 2 lần/ngày)</td></tr><tr><td>Viêm màng não, viêm não thất do vi khuẩn Gr (-)</td><td>Tiêm trong màng não/ trong não thất: 4,2 mg CBA/ ngày; tương đương 126.000 UI/ngày</td></tr></table>	Nhiễm trùng nhạy cảm	2.5 đến 5 mg CBA/kg/ngày chia thành 2 đến 4 liều (tiêm bắp, tĩnh mạch)	Giãn phế quản	Khí dung: 30 -150 mg CBA, 1 -2 lần/ngày (Tối đa: 150 mg CBA 2 lần/ngày)	Viêm màng não, viêm não thất do vi khuẩn Gr (-)	Tiêm trong màng não/ trong não thất: 4,2 mg CBA/ ngày; tương đương 126.000 UI/ngày																																																																							
Nhiễm trùng nhạy cảm	2.5 đến 5 mg CBA/kg/ngày chia thành 2 đến 4 liều (tiêm bắp, tĩnh mạch)																																																																															
Giãn phế quản	Khí dung: 30 -150 mg CBA, 1 -2 lần/ngày (Tối đa: 150 mg CBA 2 lần/ngày)																																																																															
Viêm màng não, viêm não thất do vi khuẩn Gr (-)	Tiêm trong màng não/ trong não thất: 4,2 mg CBA/ ngày; tương đương 126.000 UI/ngày																																																																															

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC	
	Colistin (Kháng sinh, polypeptid)		Viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy do trực khuẩn Gr (-) kháng thuốc, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp	Khí dung: 150 mg CBA (4.500.000 UI) trong 60 phút, mỗi 8 giờ, trong 14 ngày, hoặc đến khi cai máy thở (7-19 ngày)				
				IV: Liều tải: 300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI				
				Sau đó: 300 – 360 mg CBA/ngày Hoặc 9.000.000 -10.800.000 chia 2 lần Sau liều tải 12 giờ				
			Nhiễm trùng nặng (do vi khuẩn đa kháng thuốc nhạy cảm với colistin)	IV: Liều tải: 300 mg CBA Hoặc 9.000.000 UI				
				Sau đó: 300 – 360 mg CBA/ngày chia 2 lần. Sau liều tải 12 giờ				
21	Clarithromycin (Kháng sinh, Macrolid)	Uống	COPD	Viên giải phóng ngay: 500 mg mỗi 12 giờ (3 – 7 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan			
			Điều trị vi khuẩn HP	Viên giải phóng ngay: 500 mg mỗi 12 giờ (7 – 14 ngày)				
			Viêm phổi cộng đồng (BN nội trú)	Viên giải phóng ngay: 500 mg mỗi 12 giờ (5 ngày)				
			Viêm phổi cộng đồng (BN ngoại trú)	Viên giải phóng ngay: 500 mg mỗi 12 giờ hoặc 1g mỗi 24 giờ (5 ngày)				
			Viêm họng do liên cầu (nhóm A)	Viên giải phóng ngay: 250 mg mỗi 12 giờ (10 ngày)				

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
22	Doxycyclin (Kháng sinh, Tetracyclin)	Tĩnh mạch / Uống	Nhiễm trùng huyết do <i>Bartonella</i> spp., không viêm nội tâm mạc	Uống: 200 mg/ngày hoặc 100 mg mỗi 12 giờ (4 tuần). Kết hợp Gentamicin mỗi 24 giờ (2 tuần đầu)	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Viêm nội tâm mạc do <i>Bartonella</i> spp.	Uống: 100 mg mỗi 12 giờ (6 – 12 tuần). Kết hợp Gentamicin (2 tuần đầu)			
			Nhiễm trùng vết thương, vết cắn	Uống, IV: 100 mg mỗi 12 giờ (3- 5 ngày)			
			Viêm đốt sống do Brucella	Uống: 100 mg x 2 lần/ngày (ít nhất 12 tuần)			
			Viêm mô tế bào (nhẹ - trung bình, MRSA)	Uống: : 100 mg x 2 lần/ngày (5 – 14 ngày)			
			COPD, trầm trọng cấp tính	Uống: 200 mg/ ngày (5 – 7 ngày)			
			Viêm màng phổi do hoá chất (tác nhân xơ cứng gây tràn dịch màng phổi)	Tiêm trong phổi: 500 mg trong 30 – 100 ml NS, kết hợp gây tê tại chỗ (10 ml Lidocain 1% hoặc 20 ml Mepivacain 2%)			
			Viêm phổi cộng đồng, bệnh nhân nội trú	Uống, IV: 100 mg mỗi 12 giờ, kết hợp kháng sinh thích hợp (Tối thiểu 5 ngày)			
			Viêm vùng chậu, bệnh nhân nội trú (PID nặng)	IV, Uống: 100 mg mỗi 12 giờ, kết hợp với cefoxitin hoặc cefotetan, chuyển sang uống, sau > 24h cải thiện (14 ngày)			

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC						
23	Ertapenem (Kháng sinh, Carbapenem)	Tĩnh mạch/Bắp	Nhiễm trùng vết thương, vết cắn	IV: 1 g mỗi 24 giờ (5 – 14 ngày)	Không chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan <table><tr><th>ClCr (ml/ph/1.73m²)</th><th>Liều hiệu chỉnh</th></tr><tr><td>> 30</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>≤ 30 và bệnh thận giai đoạn cuối</td><td>500 mg mỗi 24 giờ</td></tr></table>		ClCr (ml/ph/1.73m ²)	Liều hiệu chỉnh	> 30	Không cần hiệu chỉnh	≤ 30 và bệnh thận giai đoạn cuối	500 mg mỗi 24 giờ	IHD IV: 500 mg mỗi 24 giờ Khi dùng liều hàng ngày trong vòng 6 giờ trước khi chạy thận, cần bổ sung liều 150 mg sau khi chạy thận Khi dùng Ertapenem ít nhất 6 giờ trước khi chạy thận nhân tạo, không cần dùng liều bổ sung.	CVVHD/ CVVHDF IV: 1g mỗi 24 giờ
			ClCr (ml/ph/1.73m ²)	Liều hiệu chỉnh										
			> 30	Không cần hiệu chỉnh										
			≤ 30 và bệnh thận giai đoạn cuối	500 mg mỗi 24 giờ										
			Nhiễm trùng máu, vi khuẩn Gr(-) nhạy cảm	IV: 1 g mỗi 24 giờ (7 – 14 ngày)										
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường	IM, IV: 1 g mỗi 24 giờ (2 - 4 tuần)										
			Viêm túi mật cấp tính	IV: 1 g mỗi 24 giờ, tiếp tục 1 ngày sau cắt túi mật, đến khi lâm sàng ổn định										
			Nhiễm trùng ổ bụng: ruột thừa thủng, áp xe ruột thừa, viêm đường mật, viêm túi thừa	IM, IV: 1 g mỗi 24 giờ (4 - 7 ngày)										
			Viêm tuỷ xương, và/hoặc viêm đĩa đệm, Gr(-) nhạy cảm	IV: 1 g mỗi 24 giờ (6 tuần)										
			Viêm phổi mắc phải cộng đồng, không do <i>P. aeruginosa</i>	IM, IV: 1 g mỗi 24 giờ (5 ngày), kết hợp kháng sinh thích hợp										
			Viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy	IV: 1 g mỗi 24 giờ (7 ngày)										
			Nhiễm trùng da, mô mềm, phẫu thuật	IV: 1 g mỗi 24 giờ										
Nhiễm trùng da, mô mềm hoại tử	IV: 1 g mỗi 24 giờ, kết hợp kháng sinh thích hợp													
Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp:viêm bể thận	IM, IV: 1g liều duy nhất, sau 5 - 14 ngày, chuyển sang uống													
24	Erythromycin (Kháng sinh, Macrolid)	Uống	Nhiễm trùng niệu sinh dục do Chlamydia trachomatis	500 mg mỗi 6 giờ hoặc 800 mg mỗi 6 giờ (7 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều		Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều						
			COPD	200 – 400 mg mỗi 24 giờ hoặc 250 mg mỗi 12 giờ										
			U hạt bẹn (Granuloma inguinale)	500 mg mỗi 6 giờ (21 ngày)										

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC						
25	Fluconazol (Kháng nấm)	Tĩnh mạch/ Uống	Nhiễm nấm máu do <i>Candida</i> Điều trị ban đầu	Liều tải: 800 mg mỗi 24 giờ	Không chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan <table><tr><th>CrCl (ml/ph)</th><th>Liều dùng trên suy thận</th></tr><tr><td>> 50</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>≤ 50</td><td>Giảm 50% liều</td></tr></table>		CrCl (ml/ph)	Liều dùng trên suy thận	> 50	Không cần hiệu chỉnh	≤ 50	Giảm 50% liều	IHD Liều tải, liều chỉ định: không hiệu chỉnh Liều duy trì: Dùng 3 lần/tuần PD: IV, Uống Liều tải: Dùng 100% liều Liều duy trì: Giảm 50% liều	CVVH/CVVHD/ CVVHDF: IV, Uống Liều khuyến cáo 200 mg mỗi 24 giờ Dùng 400 mg mỗi 24 giờ CVVH/CVVHD/ CVVHDF: IV, Uống Liều khuyến cáo 400 mg mỗi 24 giờ Dùng liều tải: 800 mg Duy trì: 800 mg mỗi 24 giờ chia 1-2 lần CVVH/CVVHD/ CVVHDF: IV, Uống Liều khuyến cáo: 800 mg mỗi 24 giờ Dùng liều tải: 1,2g Duy trì: 1,2g mỗi 24 giờ chia 1-2 lần
				CrCl (ml/ph)			Liều dùng trên suy thận							
			> 50	Không cần hiệu chỉnh										
			≤ 50	Giảm 50% liều										
			Sau đó: 400 mg mỗi 24 giờ.											
			Nhiễm nấm máu do <i>Candida</i> Xuống thang	Phân lập khác với <i>C. glabrata</i> . Uống 400 mg mỗi 24 giờ										
				Phân lập <i>C.glabrata</i> , nhạy Fluconazole. Uống 800 mg mỗi 24 giờ										
			Nhiễm <i>Candida</i> xâm lấn (bệnh nhân không giảm bạch cầu tại ICU, sốt, nguyên nhân không xác định)	Liều tải: 800 mg mỗi 24 giờ										
				Sau đó: 400 mg mỗi 24 giờ (≥ 14 ngày, sau cấy máu âm tính)										
			Nhiễm nấm <i>Candida</i> thực quản	Liều tải: 400 mg mỗi 24 giờ										
				Sau đó, 200 - 400 mg mỗi 24 giờ (14 ngày)										
			Nhiễm trùng ổ bụng do <i>Candida</i> , không kháng fluconazole	Liều tải: 800 mg mỗi 24 giờ										
				Sau đó: 400 mg mỗi 24 giờ (≥14 ngày)										
			Nhiễm nấm <i>Candida</i> miệng, hầu họng	Liều tải: 200 mg mỗi 24 giờ										
Sau đó: 100 - 200 mg mỗi 24 giờ (7-14 ngày)														

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC														
	Fluconazol (Kháng nấm)		Viêm phúc mạc do Candida, liên quan đến lọc máu qua màng bụng (PD)	Liều tải: 200 mg mỗi 24 giờ																	
				Sau đó, 100 – 200 mg mỗi 24 giờ(2 – 4 tuần)																	
			Viêm tĩnh mạch huyết khối do Candida	400 - 800 mg mỗi 24 giờ (≥ 2 tuần)																	
			Viêm bàng quan do Candida	Uống: 200 mg mỗi 24 giờ (2 tuần)																	
			Viêm bề thận	Uống: 200 – 400 mg mỗi 24 giờ (2 tuần)																	
			Bệnh nấm Candida. Dự phòng ở bệnh nhân ICU (nguy cơ cao)	Liều tải: 800 mg mỗi 24 giờ																	
				Sau đó, 400 mg mỗi 24 giờ																	
			Nhiễm trùng liên quan lọc máu màng bụng, phòng ngừa nhiễm nấm thứ phát	Uống: 200 mg mỗi 24 giờ hoặc 100 mg mỗi 24 giờ (kết hợp kháng sinh khác)																	
Viêm màng não do nấm Coccidioides	Uống: 400 mg – 1,2g mỗi 24 giờ																				
26	Fosfomycin (Kháng sinh, dẫn xuất acid fosfonic)	Tĩnh mạch	Viêm màng não do vi khuẩn	16 - 24 g chia 3 - 4 lần mỗi ngày	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều hiệu chỉnh</th></tr><tr><td>≥ 80</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>40 - 80</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>40</td><td>70% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ</td></tr><tr><td>30</td><td>60% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ</td></tr><tr><td>20</td><td>40% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ</td></tr><tr><td>10</td><td>2% liều thông thường mỗi 12 – 24 giờ</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh	≥ 80	Không cần hiệu chỉnh	40 - 80	Không cần hiệu chỉnh	40	70% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ	30	60% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ	20	40% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ	10	2% liều thông thường mỗi 12 – 24 giờ	Bệnh nhân trải qua thẩm tách ngắt quãng mạn tính (mỗi 48 giờ) nên nhận 2 g fosfomycin vào cuối mỗi lần lọc máu	Không cần hiệu chỉnh liều
			ClCr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh																	
			≥ 80	Không cần hiệu chỉnh																	
			40 - 80	Không cần hiệu chỉnh																	
			40	70% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ																	
			30	60% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ																	
20	40% liều thông thường mỗi 8 – 12 giờ																				
10	2% liều thông thường mỗi 12 – 24 giờ																				
Viêm tủy xương	12 - 24 g chia 2 - 3 lần mỗi ngày																				
Viêm phổi bệnh viện																					
Nhiễm trùng đường tiết niệu phức tạp	12 - 16 g chia 2 - 3 lần mỗi ngày																				

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU NGẮT QUẢNG		LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU LIÊN TỤC																
27	Gentamicin (Kháng sinh, Aminoglycosid)	Tĩnh mạch/ Bắp	Nhiễm khuẩn Gr (-)	IV, IM: 3 - 5 mg/kg/ngày chia 3 liều	Không hiệu chỉnh liều trên suy gan		IHD Liều tải: 2-3 mg/kg		CVVH/CVVHD/ CVVHDF																
			Nhiễm trùng do <i>Bartonella</i> spp.	IV: 3 mg/kg/ngày trong 1 hoặc 3 liều, kết hợp Doxycyclin (2 tuần)																					
			Nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, vi khuẩn Gr(-) kháng thuốc	IV: 5-7 mg/kg/ngày chia 3 liều																					
			Bệnh Brucella (Brucellosis)	IV, IM: 5 mg/kg/ngày. (5 - 14 ngày) Kết hợp Doxycyclin	Liều thông thường: 1.7mg/kg mỗi 8 giờ hoặc 5-7 mg/kg mỗi 24 giờ		Liều tải: 2-3 mg/kg		Nhiễm trùng tiết niệu nhẹ	Liều tải: 2-3 mg/kg Sau đó 1 mg/kg mỗi 24- 36 giờ															
			Nhiễm trùng thần kinh trung ương, liên quan đến chăm sóc sức khỏe: nhiễm trùng dịch não tủy	Ban đầu: 4-8mg/kg, tiêm qua ống dẫn lưu não thất 15-60 phút. Sau đó, điều chỉnh liều mục tiêu: 10-20 lần MIC																					
			Viêm nội tâm mạc do <i>Enterococcus</i> spp	IV,IM: 1 mg/kg mỗi 8 giờ (4 - 6 tuần)																					
			Viêm nội tâm mạc do <i>Staphylococcus</i> spp	IV,IM: 1 mg/kg mỗi 8 giờ (2 tuần đầu). Sau đó, kết hợp kháng sinh khác (tổng ≥ 6 tuần)																					
			Viêm màng não do <i>Enterococcus</i> spp	IV: 5 mg/kg/ngày chia 1 hoặc 3 liều																					
			Viêm màng não do <i>Listeria monocytogenes</i>	IV: 5 mg/kg/ngày chia 1 hoặc 3 liều. Kết hợp với Ampicillin hoặc Penicillin (7 - 21 ngày)																					
			Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp: viêm bể thận, viêm bàng quang	IV, IM: 5 mg/kg mỗi 24 giờ (5-14 ngày)																					
Liều 1 lần/ngày		GFR (ml/ph) Liều hiệu chỉnh		Nhiễm trùng tiết niệu nhẹ		1 mg/kg mỗi 48-72 giờ																			
								CICr (ml/ph) Liều hiệu chỉnh																	
										>50	Không cần hiệu chỉnh														
										10 – 50	Sử dụng mỗi 12-48 giờ														
										< 10	Sử dụng mỗi 48-72 giờ														
										≥ 60	Sử dụng mỗi 24 giờ														
										40 – 59	Sử dụng mỗi 36 giờ														
20 – 39	Sử dụng mỗi 48 giờ																								
< 20	Theo dõi và giảm liều khi nồng độ gentamicin < 1 mcg/ml hoặc dùng liều thông thường																								
Theo dõi và giảm liều khi nồng độ gentamicin < 1 mcg/ml hoặc dùng liều thông thường		Nhiễm trùng tiết niệu trung bình đến nặng		1 - 1,5 mg/kg mỗi 48-72 giờ																					
						Nhiễm trùng Gr(-) toàn thân		1,5 - 2 mg/kg mỗi 48-72 giờ																	
										Nhiễm trùng Gr(-) toàn thân		1,5 - 2 mg/kg mỗi 48-72 giờ													
														Nhiễm trùng Gr(-) toàn thân		1,5 - 2 mg/kg mỗi 48-72 giờ									
																		Nhiễm trùng Gr(-) toàn thân		1,5 - 2 mg/kg mỗi 48-72 giờ					
																						Nhiễm trùng Gr(-) toàn thân		1,5 - 2 mg/kg mỗi 48-72 giờ	

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC	
28	Imipenem Cilastatin (Kháng sinh, Carbapenem)	Tĩnh mạch	Nhiễm khuẩn do <i>Burkholderia pseudomallei</i> (melioidosis)	Ban đầu: 20 mg/kg mỗi 8 giờ (ít nhất 10 ngày)	Không hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan			
				Hoặc 25 mg/kg (Tối đa 1g) mỗi 6 giờ (ít nhất 10 ngày)				
			Nhiễm trùng ổ bụng phức tạp	IV: 500 mg mỗi 6 giờ hoặc 1g mỗi 8 giờ (4 - 7 ngày)				
			Sốt bạch cầu trung tính	500 mg mỗi 6 giờ				
			Nhiễm trùng da mô mềm hoặc nhiễm trùng xương do <i>M.abscessus</i>	500 mg mỗi 6 -12 giờ, kết hợp kháng sinh thích hợp				
			Viêm phổi cộng đồng do Gr(-) kháng thuốc, <i>P.aeruginosa</i>	500 mg mỗi 6 giờ (Tối thiểu 5 ngày)				
			Viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy	500 mg mỗi 6 giờ (7 ngày)				
			Nhiễm trùng hoại tử da mô mềm (phối hợp kháng sinh khác)	1 g mỗi 6-8 giờ. Kết hợp với kháng sinh kháng MRSA (vancomycin, linezolid, daptomycin) (đến khi lâm sàng cải thiện, bệnh nhân hết sốt 48-72h)				
			Nhiễm trùng tại chỗ phẫu thuật: đường ruột, đường sinh dục	500 mg mỗi 6 giờ				
			Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp: viêm bể thận	500 mg mỗi 6 giờ (10 -14 ngày)				

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC
29	Itraconazole (Kháng nấm)	Uống	Nhiễm trùng nấm Aspergillus xâm lấn	200mg mỗi 12 giờ (6 - 12 tuần)	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Nhiễm nấm Blastomycosis	200 mg mỗi 8 giờ trong 3 ngày, Sau đó 200 mg mỗi 12 giờ (6 - 12 tháng)			
			Nhiễm nấm Candida thực quản	200 mg mỗi 24 giờ (14 - 21 ngày)			
			Nhiễm nấm Chromomycosis	200 mg mỗi 24 giờ (6 tháng)			
			Bệnh nấm Histoplasma (Histoplasmosis)	200 mg mỗi 8 giờ (3 ngày). Sau đó, 200 mg mỗi 12 giờ (6 - 12 tuần)			
30	Linezolid (Kháng sinh, Oxazolidinone)	Tĩnh mạch/Uống	Nhiễm trùng máu do Enterococci kháng vancomycin	600 mg mỗi 12 giờ (7 - 14 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Nhiễm trùng máu do Staphylococcus aureus kháng methicillin	600 mg mỗi 12 giờ (≥ 14 ngày)			
			Nhiễm trùng thần kinh trung ương: Staphylococcus spp kháng methicillin hoặc Cutibacterium acnes	600 mg mỗi 12 giờ (10 - 14 ngày)			
			Xơ nang, làm nặng phổi cấp tính	600 mg mỗi 12 giờ (10 ngày - 3 tuần)			
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường	600 mg mỗi 12 giờ (2 - 4 tuần)			
			Áp xe nội sọ, áp xe màng cứng cột sống	600 mg mỗi 12 giờ (4 - 8 tuần)			
			Viêm màng não: Enterococci kháng penicillin, ampicillin và vancomycin Staphylococcus, MRSA	600 mg mỗi 12 giờ (4 - 8 tuần)			
			Viêm phổi do S.aureus kháng methicillin	600 mg mỗi 12 giờ (≥ 7 ngày)			

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA CẤP CỨU VÀ HÔI SỨC TÍCH CỰC						BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM																								
STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU NGẮT QUẢNG		LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU LIÊN TỤC																						
	Linezolid (Kháng sinh, Oxazolidinone)		Viêm khớp nhiễm khuẩn do MRSA	600 mg mỗi 12 giờ (3 - 4 tuần)	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều		Không cần hiệu chỉnh liều																						
		Nhiễm trùng da, mô mềm do Gr(+) kháng thuốc: MRSA	600 mg mỗi 12 giờ (5 - 14 ngày)																											
		Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp: viêm bể thận viêm bàng quang có nhiễm trùng hệ thống	600 mg mỗi 12 giờ (7 - 14 ngày)																											
31	Levofloxacin (Kháng sinh, Fluoroquinolon)	Tĩnh mạch/Uống	Viêm màng não	750 mg mỗi 24 giờ, kết hợp kháng sinh thích hợp (2-3 tuần)	Không hiệu chỉnh liều trên suy gan				Liều 500 mg mỗi 24 giờ CAPD <table><tr><td>Liều tải</td><td>500 - 750 mg</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>250 mg mỗi 48 giờ</td></tr></table>		Liều tải	500 - 750 mg	Sau đó	250 mg mỗi 48 giờ																
			Liều tải	500 - 750 mg																										
			Sau đó	250 mg mỗi 48 giờ																										
			Nhiễm trùng vết thương, vết cắn	750 mg mỗi 24 giờ, kết hợp kháng sinh cho vi khuẩn kỵ khí (3-5 ngày)																										
			COPD	500 mg mỗi 24 giờ (3-7 ngày)	<table><tr><th>Clcr (ml/ph)</th><th>Liều hiệu chỉnh 250 mg mỗi 24h</th><th>Liều hiệu chỉnh 500 mg mỗi 24h</th><th>Liều hiệu chỉnh 750 mg mỗi 24h</th></tr><tr><td>20 - 49</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td><td>Liều tải 500mg</td><td>750 mg mỗi 48 giờ</td></tr><tr><td>10 - 19</td><td>250 mg mỗi 48 giờ</td><td>Liều tải 500mg</td><td>Liều tải 750 mg</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sau đó 250 mg mỗi 48 giờ</td><td>Sau đó 500mg mỗi 48 giờ</td></tr></table>				Clcr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh 250 mg mỗi 24h	Liều hiệu chỉnh 500 mg mỗi 24h	Liều hiệu chỉnh 750 mg mỗi 24h	20 - 49	Không cần hiệu chỉnh	Liều tải 500mg	750 mg mỗi 48 giờ	10 - 19	250 mg mỗi 48 giờ	Liều tải 500mg	Liều tải 750 mg			Sau đó 250 mg mỗi 48 giờ	Sau đó 500mg mỗi 48 giờ	Liều 750 mg mỗi 24 giờ CAPD <table><tr><td>Liều tải</td><td>750 mg</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>500 mg mỗi 48 giờ</td></tr></table>		Liều tải	750 mg	Sau đó	500 mg mỗi 48 giờ
			Clcr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh 250 mg mỗi 24h	Liều hiệu chỉnh 500 mg mỗi 24h	Liều hiệu chỉnh 750 mg mỗi 24h																								
			20 - 49	Không cần hiệu chỉnh	Liều tải 500mg	750 mg mỗi 48 giờ																								
			10 - 19	250 mg mỗi 48 giờ	Liều tải 500mg	Liều tải 750 mg																								
					Sau đó 250 mg mỗi 48 giờ	Sau đó 500mg mỗi 48 giờ																								
			Liều tải	750 mg																										
			Sau đó	500 mg mỗi 48 giờ																										
			COPD do P.aeruginosa	750 mg mỗi 24 giờ	Liều hiệu chỉnh 750 mg hoặc 1g mỗi 24h <table><tr><td>< 30</td><td>Dùng 750 mg hoặc 1g, 3 lần mỗi tuần</td></tr></table>				< 30	Dùng 750 mg hoặc 1g, 3 lần mỗi tuần	CVVH <table><tr><td>Liều tải</td><td>500 - 750 mg</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>250 mg mỗi 24 giờ</td></tr></table>		Liều tải	500 - 750 mg	Sau đó	250 mg mỗi 24 giờ														
< 30	Dùng 750 mg hoặc 1g, 3 lần mỗi tuần																													
Liều tải	500 - 750 mg																													
Sau đó	250 mg mỗi 24 giờ																													
Nhiễm trùng chân do tiểu đường, nặng	750 mg mỗi 24 giờ																													
Nhiễm trùng ổ bụng: thủng ruột thừa, áp xe ruột thừa, viêm túi thừa, viêm túi mật cấp	750 mg mỗi 24 giờ, kết hợp Metronidazole (4-7 ngày)					CVVHD <table><tr><td>Liều tải</td><td>500 - 750 mg</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>250 - 500 mg mỗi 24 giờ</td></tr></table>		Liều tải	500 - 750 mg	Sau đó	250 - 500 mg mỗi 24 giờ																			
Liều tải	500 - 750 mg																													
Sau đó	250 - 500 mg mỗi 24 giờ																													
Viêm tủy xương	750 mg mỗi 24 giờ (≥ 6 tuần)					CVVHDF <table><tr><td>Liều tải</td><td>500 - 750 mg</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>250 - 750 mg mỗi 24 giờ</td></tr></table>		Liều tải	500 - 750 mg	Sau đó	250 - 750 mg mỗi 24 giờ																			
Liều tải	500 - 750 mg																													
Sau đó	250 - 750 mg mỗi 24 giờ																													
Viêm phổi cộng đồng	750 mg mỗi 24 giờ (5 ngày)																													
Viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy	750 mg mỗi 24 giờ (7 ngày)																													
Viêm mô tế bào có mũ áp xe, nhiễm Gr(-)	750 mg mỗi 24 giờ, kết hợp kháng sinh thích hợp (5-14 ngày)																													

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC								
33	Metronidazole (Kháng nấm)	Tĩnh mạch/ Uống	Bệnh amip, đường ruột	Uống: 500 – 750 mg mỗi 8 giờ (7 -10 ngày)	<table><tr><td>Child - Pugh A hoặc B</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>Child Pugh C</td><td>Giảm ½ liều</td></tr></table>		Child - Pugh A hoặc B	Không cần hiệu chỉnh	Child Pugh C	Giảm ½ liều	<table><tr><td>IHD</td></tr><tr><td>500 mg mỗi 8-12 giờ</td></tr></table>	IHD	500 mg mỗi 8-12 giờ	<table><tr><td>CVVH/CVVHD/ CVVHDF</td></tr><tr><td>500 mg mỗi 6-12 giờ</td></tr></table>	CVVH/CVVHD/ CVVHDF	500 mg mỗi 6-12 giờ
			Child - Pugh A hoặc B	Không cần hiệu chỉnh												
			Child Pugh C	Giảm ½ liều												
			IHD													
			500 mg mỗi 8-12 giờ													
			CVVH/CVVHD/ CVVHDF													
			500 mg mỗi 6-12 giờ													
			Nhiễm trùng vết thương, vết cắn động vật/ người	Uống, IV: 500 mg mỗi 8 giờ. Dự phòng: 3 – 5 ngày Điều trị: 5 – 14 ngày												
Nhiễm trùng ổ bụng	Uống, IV: 500 mg mỗi 8 giờ (4 - 7 ngày)															
Nhiễm trùng da mô mềm, nhiễm trùng hoại tử	IV: 500 mg mỗi 6 giờ. (lâm sàng cải thiện)															
Nhiễm trùng vết mổ	IV: 500 mg mỗi 8 giờ. Kết hợp kháng sinh thích hợp															
Viêm phổi sặc	Uống, IV: 500 mg mỗi 8 giờ. Kết hợp beta lactam (7 ngày)															
Áp xe nội sọ	IV: 500 mg mỗi 6 – 8 giờ. Kết hợp kháng sinh khác (6 – 8 tuần)															
			Viêm vùng chậu, nhẹ đến trung bình	Uống: 500 mg mỗi 12 giờ (14 ngày)												
34	Moxifloxacin (Kháng sinh, Fluoroquinolone)	Tĩnh mạch /Uống	Đợt cấp của viêm phế quản mãn tính	400 mg mỗi 24 giờ (5 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều		Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều								
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường	400 mg mỗi 24 giờ												
			Viêm phổi cộng đồng	400 mg mỗi 24 giờ (5 ngày)												
			Nhiễm trùng ổ bụng, phức tạp	400 mg mỗi 24 giờ (4 - 7 ngày)												
			Viêm màng não	400 mg mỗi 24 giờ. kết hợp vancomycin hoặc cephalosporin 3												
			Nhiễm trùng da mô mềm, có biến chứng	400 mg mỗi 24 giờ (7 - 21 ngày)												

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

KHOA CẤP CỨU VÀ HÔI SỨC TÍCH CỰC

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN			LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU NGẮT QUẢNG		LIỀU DÙNG TRONG LỘC MÁU LIÊN TỤC	
35	Piperacilin Tazobactam (Kháng sinh, Penicillin)	Tĩnh mạch	Nhiễm trùng vết thương, vết cắn	3.375g mỗi 6 - 8 giờ (5 - 14 ngày)	Không hiệu chỉnh liều trên suy gan			IHD 2.25g mỗi 12 giờ 2.25g mỗi 8 giờ viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy		4,5g mỗi 8 giờ CVVH/ CVVHD/ CVVHDF Liều tải 4,5g Sau đó 2,25g mỗi 6 giờ	
			Nhiễm trùng huyết, Gr(-), P.aeruginosa	4,5 g mỗi 6 giờ (7 - 14 ngày)							
			Xơ nang, làm nặng phổi cấp, P.aeruginosa	4,5 g mỗi 6 giờ (10 - 3 tuần)							
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường, nặng	3,375g mỗi 6 giờ Hoặc 4.5 g mỗi 6 giờ (2 - 4 tuần)							
			Viêm túi mật cấp	3,375g hoặc 4.5 g mỗi 6 giờ. Tiếp tục sau 1 ngày cắt túi mật, lâm sàng ổn định							
			Nhiễm trùng ổ bụng: viêm đường mật, ruột thừa thủng, viêm túi thừa, áp xe ổ bụng	3,375g hoặc 4.5 g mỗi 6 giờ (4 - 7 ngày)							
			Viêm phổi cộng đồng, Gr(-) kháng thuốc, P.aeruginosa	4.5 g mỗi 6 giờ (≥ 5 ngày)							
			Viêm phổi bệnh viện, Viêm phổi thở máy, Gr(-) kháng thuốc, P.aeruginosa	4.5 g mỗi 6 giờ (7 ngày)							
			Nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, P.aeruginosa	4.5 g mỗi 6 giờ. Kết hợp kháng sinh thích hợp (7 - 10 ngày)							
			Nhiễm trùng da và mô mềm: nhiễm trùng nặng, hoại tử, nhiễm trùng chỗ phẫu thuật	3,375g mỗi 6 giờ hoặc 4.5 g mỗi 8 giờ							
			Nhiễm trùng da mô mềm do P.aeruginosa	4.5 g mỗi 6 giờ (10 - 14 ngày)							
			Nhiễm trùng tiết niệu, phức tạp: viêm bể thận	3,375g mỗi 6 giờ							
			Nhiễm trùng tiết niệu, Pseudomonas	4.5 g mỗi 6 giờ (5 - 14 ngày)							

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Vennuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC													
36	Spiramycin (Kháng sinh, Macrolide)	Uống	Nhiễm trùng nhẹ đến trung bình	6.000.000 đến 9.000.000 đơn vị (2 - 3 viên Rovamycin 500mg mỗi 12 giờ)	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều													
			Nhiễm trùng nặng	12.000.000 đến 15.000.000 đơn vị (4 - 5 viên Rovamycin 500mg mỗi 12 giờ)																
37	Teicoplanin (Kháng sinh, Glycopeptid)	Tĩnh mạch/Bắp	Viêm nội tâm mạc	<table><tr><td>Liều tải</td><td>12 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 – 5 liều đầu</td></tr><tr><td>Duy trì</td><td>12 mg/kg mỗi 24 giờ</td></tr></table>	Liều tải	12 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 – 5 liều đầu	Duy trì	12 mg/kg mỗi 24 giờ	Không hiệu chỉnh trên bệnh nhân suy gan <table><tr><th colspan="2">Sau ngày điều trị thứ 4</th></tr><tr><th>Clcr (ml/ph)</th><th>Liều hiệu chỉnh trên suy thận</th></tr><tr><td>> 80</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>30 – 80</td><td>50% liều thông thường mỗi 24 giờ</td></tr><tr><td>< 30</td><td>30% liều thông thường mỗi 24 giờ</td></tr></table>	Sau ngày điều trị thứ 4		Clcr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh trên suy thận	> 80	Không cần hiệu chỉnh	30 – 80	50% liều thông thường mỗi 24 giờ	< 30	30% liều thông thường mỗi 24 giờ	Teicoplanin không được loại bỏ bằng cách chạy thận nhân tạo.
Liều tải	12 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 – 5 liều đầu																			
Duy trì	12 mg/kg mỗi 24 giờ																			
Sau ngày điều trị thứ 4																				
Clcr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh trên suy thận																			
> 80	Không cần hiệu chỉnh																			
30 – 80	50% liều thông thường mỗi 24 giờ																			
< 30	30% liều thông thường mỗi 24 giờ																			
		Nhiễm trùng xương khớp	<table><tr><td>Duy trì</td><td>12 mg/kg mỗi 24 giờ</td></tr></table>	Duy trì	12 mg/kg mỗi 24 giờ															
Duy trì	12 mg/kg mỗi 24 giờ																			
		Nhiễm trùng da, mô mềm	<table><tr><td>Liều tải</td><td>6 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 liều đầu</td></tr><tr><td>Duy trì</td><td>6 mg/kg mỗi 24 giờ</td></tr></table>	Liều tải	6 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 liều đầu	Duy trì	6 mg/kg mỗi 24 giờ													
Liều tải	6 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 liều đầu																			
Duy trì	6 mg/kg mỗi 24 giờ																			
		Viêm phổi																		
		Nhiễm trùng tiết niệu	<table><tr><td>Duy trì</td><td>6 mg/kg mỗi 24 giờ</td></tr></table>	Duy trì	6 mg/kg mỗi 24 giờ															
Duy trì	6 mg/kg mỗi 24 giờ																			
38	Tetracyclin (Kháng sinh, dẫn xuất Tetracyclin)	Uống	Nhiễm khuẩn thông thường	250 - 500 mg mỗi 6 - 12 giờ	Không hiệu chỉnh trên bệnh nhân suy gan <table><tr><th colspan="2">Liều điều chỉnh 250 - 500 mg mỗi 6 - 12 giờ</th></tr><tr><th>GFR (ml/ph)</th><th>Liều hiệu chỉnh trên suy thận</th></tr><tr><td>> 50</td><td>Liều chỉ định mỗi 8 - 12 giờ</td></tr><tr><td>10 – 50</td><td>Liều chỉ định mỗi 12 - 24 giờ</td></tr><tr><td>< 10</td><td>Liều chỉ định mỗi 24 giờ</td></tr></table>	Liều điều chỉnh 250 - 500 mg mỗi 6 - 12 giờ		GFR (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh trên suy thận	> 50	Liều chỉ định mỗi 8 - 12 giờ	10 – 50	Liều chỉ định mỗi 12 - 24 giờ	< 10	Liều chỉ định mỗi 24 giờ	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều			
Liều điều chỉnh 250 - 500 mg mỗi 6 - 12 giờ																				
GFR (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh trên suy thận																			
> 50	Liều chỉ định mỗi 8 - 12 giờ																			
10 – 50	Liều chỉ định mỗi 12 - 24 giờ																			
< 10	Liều chỉ định mỗi 24 giờ																			
		Sốt rét nặng	250 mg mỗi 6 giờ (7 ngày). Kết hợp quinidin gluconate																	
		Sốt rét, không biến chứng	250 mg mỗi 6 giờ (7 ngày). Kết hợp quinidin sulfat																	
		Viêm nha chu	250 mg mỗi 6 giờ (10 ngày)																	

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC				
39	Tigecyclin (Kháng sinh, Glycylcyclin)	Tĩnh mạch	Viêm phổi cộng đồng	Liều tải: 100 mg Duy trì: 50 mg mỗi 12 giờ (7 - 14 ngày)	<table><tr><td>Child - Pugh A hoặc B</td><td>Không cần chỉnh</td></tr><tr><td>Child – Pugh C</td><td>Ban đầu 100 mg, Duy trì 25 mg mỗi 12 giờ</td></tr></table>		Child - Pugh A hoặc B	Không cần chỉnh	Child – Pugh C	Ban đầu 100 mg, Duy trì 25 mg mỗi 12 giờ	Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều
			Child - Pugh A hoặc B	Không cần chỉnh								
			Child – Pugh C	Ban đầu 100 mg, Duy trì 25 mg mỗi 12 giờ								
			Nhiễm trùng ổ bụng, phức tạp	Liều tải: 100 mg Duy trì: 50 mg mỗi 12 giờ (7 - 14 ngày)								
Nhiễm trùng da phức tạp	Liều tải: 100 mg Duy trì: 50 mg mỗi 12 giờ (5 - 14 ngày)											
40	Tinidazol (Kháng nấm)	Uống	Bệnh amip, đường ruột	2g mỗi 24 giờ (3 ngày)	Không cần hiệu chỉnh liều		Không cần hiệu chỉnh liều	Không cần hiệu chỉnh liều				
			Bệnh amip, áp xe gan	2g mỗi 24 giờ (3 - 5 ngày)								
			Viêm âm đạo	2g mỗi 24 giờ (2 ngày) hoặc 1g mỗi 24 giờ (5 ngày)								
			Viêm âm đạo tái phát	500 mg mỗi 12 giờ (7 ngày)								
			Viêm niệu đạo	2g một liều duy nhất								
			Điều trị HP	500 mg mỗi 12 giờ. Kết hợp Clarithromycin: 500mg mỗi 12 giờ, Amoxicillin: 1 g mỗi 12 giờ, PPI (10-14 ngày)								

BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM

STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC								
41	Trimethromprim Sulfamethoxazole (16mg TMP + 80mg SMX/ml) (Kháng sinh, dẫn xuất Sulfonamid)	Tĩnh mạch/Uống	Nhiễm trùng vết thương, vết cắn	1 viên mỗi 12 giờ (3 - 5 ngày)	Không hiệu chỉnh liều trên suy gan <table><tr><th>Clcr (ml/ph)</th><th>Liều hiệu chỉnh trên suy thận</th></tr><tr><td>> 30</td><td>Không cần hiệu chỉnh</td></tr><tr><td>15 – 30</td><td>50% liều khuyến cáo</td></tr><tr><td>< 15</td><td>Không nên dùng</td></tr></table>	Clcr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh trên suy thận	> 30	Không cần hiệu chỉnh	15 – 30	50% liều khuyến cáo	< 15	Không nên dùng	Hemodialysis 5 mg/kg (TMP) mỗi 24 giờ sau lọc	CVVH/CVVHD/ CVVHDF 2.5 – 7.5 mg/kg (TMP) mỗi 12 giờ
			Clcr (ml/ph)	Liều hiệu chỉnh trên suy thận											
			> 30	Không cần hiệu chỉnh											
			15 – 30	50% liều khuyến cáo											
			< 15	Không nên dùng											
			COPD	1 viên mỗi 12 giờ (3 - 7 ngày)											
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường, Staphylococcus aureus, MRSA	2 viên mỗi 12 giờ (1 - 2 tuần)											
			Áp xe nội sọ, áp xe ngoài màng cứng	5mg/kg (TMP) mỗi 8 - 12 giờ (4 - 8 tuần)											
			Viêm màng não, L. monocytogenes, E. coli	5mg/kg (TMP) mỗi 6 – 12 giờ											
			Nhiễm khuẩn Melioidosis	40 – 60 kg: 240 mg (TMP) mỗi 12 giờ											
				> 60 kg: 320 mg (TMP) mỗi 12 giờ											
			Viêm tủy xương, do MRSA	4 mg/kg (TMP) mỗi 12 giờ. Kết hợp Rifampin											
Viêm phổi do Pneumocytis	15 – 20 mg/kg/ngày (TMP) chia 3 – 4 liều (21 ngày)														
Viêm khớp nhiễm khuẩn do MRSA	4 mg/kg (TMP) mỗi 12 giờ. (3 - 4 tuần)														
Nhiễm trùng Stenotrophomonas maltophilia, viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy, nhiễm khuẩn huyết	15 mg/kg/ngày (TMP) chia 3 - 4 liều														
Nhiễm trùng tiết niệu. phức tạp: viêm bể thận	1 viên mỗi 12 giờ (14 ngày)														

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD**: hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD**: Peritoneal dialysis; **CVVH**: Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF**: Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD**: End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC						BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM						
STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN				LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC	
42	Vancomycin (Kháng sinh, Glycopeptid)	Tĩnh mạch/ Uống	Nhiễm trùng huyết do MRSA	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (≥ 14 ngày)	Không hiệu chỉnh liều trên suy gan							
			Nhiễm trùng shunt dịch não tủy, MRSA	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ								
			Xơ nang, làm nặng phổi cấp tính, MRSA	15-20 mg/kg/liều mỗi 8 giờ (10 ngày - 3 tuần)								
			Nhiễm trùng chân do tiểu đường, nặng	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (2 - 4 tuần)								
			Nhiễm trùng ổ bụng	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ								
			Áp xe nội sọ, áp xe màng cứng cột sống	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (4 - 8 tuần)								
			Viêm màng não, MRSA, <i>S.pneumoniae</i> kháng cephalosporin và penicillin	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ								
			Viêm tuỷ xương	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (≥ 6 tuần)								
			Viêm phổi, MRSA	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (≥ 7 ngày)								
			Nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (7 - 10 ngày)								
			Nhiễm trùng da và mô mềm	15 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 12 giờ								
			Hội chứng sốc độc tố, tụ cầu khuẩn	15-20 mg/kg/liều (Tối đa 2g) mỗi 8 - 12 giờ (10 - 14 ngày)								

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC			BẢNG CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG NẤM																										
STT	THUỐC	Đường dùng	LIỀU DÙNG THÔNG THƯỜNG		LIỀU DÙNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN, SUY GAN		LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU NGẮT QUẢNG	LIỀU DÙNG TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC																					
43	Voriconazole (Kháng nấm)	Tĩnh mạch/Uống	Nhiễm trùng nấm Aspergillus xâm lấn, nhiễm trùng ngoài phổi	IV, Liều tải: 6 mg/kg (400mg) mỗi 12 giờ cho 2 liều Duy trì: 4 mg/kg (300mg) mỗi 12 giờ	<table><tr><td>Child Pugh</td><td>Liều trên bệnh nhân suy gan</td></tr><tr><td>A – B</td><td>Liều tải: không đổi Liều duy trì: giảm 50 %</td></tr><tr><td>C</td><td>Chưa có dữ liệu</td></tr></table> <table><tr><td>CrCl (ml/ph)</td><td>Liều trên bệnh nhân suy thận</td></tr><tr><td>≥ 50</td><td>Không hiệu chỉnh</td></tr><tr><td rowspan="3">< 50</td><td>Dùng Voriconazole đường uống</td></tr><tr><td>IV: Theo dõi chặt chẽ creatinin</td></tr><tr><td>IV: Thời gian điều trị 7 - 10 ngày</td></tr></table>		Child Pugh	Liều trên bệnh nhân suy gan	A – B	Liều tải: không đổi Liều duy trì: giảm 50 %	C	Chưa có dữ liệu	CrCl (ml/ph)	Liều trên bệnh nhân suy thận	≥ 50	Không hiệu chỉnh	< 50	Dùng Voriconazole đường uống	IV: Theo dõi chặt chẽ creatinin	IV: Thời gian điều trị 7 - 10 ngày	Không cần hiệu chỉnh liều	<table><tr><td colspan="2">CVVH/CVVHD/ CVVHDF</td></tr><tr><td>Liều tải</td><td>400 mg mỗi 12 giờ</td></tr><tr><td>Sau đó</td><td>200 mg mỗi 12 giờ</td></tr></table>		CVVH/CVVHD/ CVVHDF		Liều tải	400 mg mỗi 12 giờ	Sau đó	200 mg mỗi 12 giờ
				Child Pugh			Liều trên bệnh nhân suy gan																						
			A – B	Liều tải: không đổi Liều duy trì: giảm 50 %																									
			C	Chưa có dữ liệu																									
			CrCl (ml/ph)	Liều trên bệnh nhân suy thận																									
			≥ 50	Không hiệu chỉnh																									
			< 50	Dùng Voriconazole đường uống																									
				IV: Theo dõi chặt chẽ creatinin																									
				IV: Thời gian điều trị 7 - 10 ngày																									
			CVVH/CVVHD/ CVVHDF																										
Liều tải	400 mg mỗi 12 giờ																												
Sau đó	200 mg mỗi 12 giờ																												
Nấm Candida huyết ở BN không giảm bạch cầu, nhiễm nấm Candida lan rộng ở da, nhiễm trùng bụng, thận, thành bàng quang, vết thương	IV, Liều tải: 6 mg/kg (400mg) mỗi 12 giờ cho 2 liều Duy trì: 4 mg/kg (300mg) mỗi 12 giờ																												
	Uống < 40 kg: 100 mg mỗi 12 giờ ≥ 40 kg: 200 mg mỗi 12 giờ (14 ngày sau cấy máu âm tính đầu tiên)																												
Nấm Candida glabrata, mẫn cảm voriconazole	Uống: 3 - 4 mg/kg (200 - 300 mg) mỗi 12 giờ																												
Nấm Candida thực quản	< 40 kg: 100 mg mỗi 12 giờ. Tối đa 300 mg/ngày ≥ 40 kg: 200 mg mỗi 12 giờ. Tối đa 600mg/ngày (ít nhất 14 ngày)																												
Viêm màng não do coccidioidal	IV, Liều tải: 6 mg/kg (400mg) mỗi 12 giờ cho 2 liều Duy trì: 4 mg/kg (300mg) mỗi 12 giờ																												
	Uống: 200 mg mỗi 12 giờ																												

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venuos Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRR: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD:Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis

31

TLTK: Uptodate 4/2020; Lexicomp 2020; Medicines.org.uk/EMC; Thông tin sản phẩm; **HD:** hemodialysis
IHD: Intermittent hemodialysis; **PD:** Peritoneal dialysis; **CVVH:** Continuous Veno-Venous Hemofiltration.
CVVHD: Continuous venovenous hemodialysis; **CVVHDF:** Continuous venovenous hemodiafiltration.
PIRRT: Prolonged intermittent renal replacement therapy; **ESRD:** End-stage renal disease;
CAPD: Hemodialysis/chronic ambulatory peritoneal dialysis